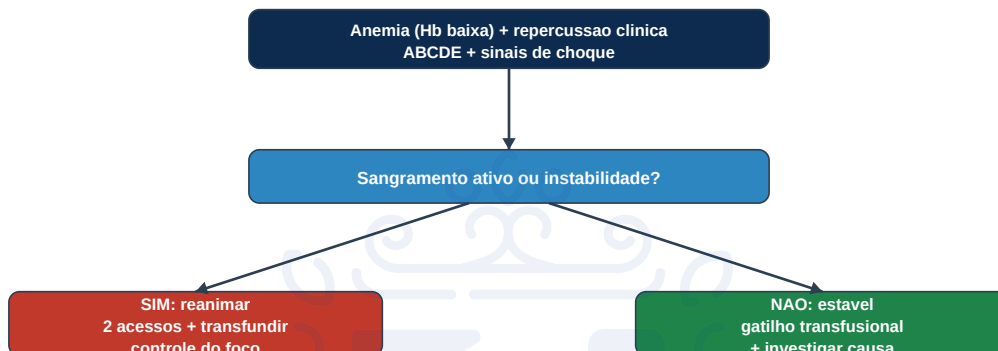


ANEMIA NO PS — ESTRATIFICAÇÃO E TRANSFUSÃO

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM NO PS

ANEMIA — DECIDIR O QUE É TEMPO-DEPENDENTE



DEFINIÇÃO

ANEMIA NO PS

- Redução da capacidade de transporte de O₂ com repercussão clínica variável
- No PS, o essencial NÃO é a etiologia exata — é separar 3 cenários:
- 1. Sangramento agudo / instabilidade (tempo-dependente)
- 2. Anemia sintomática sem instabilidade (gatilho transfusional + comorbidades)
- 3. Anemia crônica / achado incidental (investigar e tratar a causa)

QUANDO SUSPEITAR — PERGUNTAS-CHAVE

ANAMNESE DIRIGIDA

- Sangramento ativo ou recente? (melena, hematêmese, hematoquezia, menorragia, trauma)
- Sintomas de hipóxia/anemia? dispneia aos mínimos esforços, dor torácica, síncope, palpitações, confusão
- Comorbidades críticas? coronariopatia / IC, DPOC grave, AVC recente, DRC
- Uso de anticoagulante / antiagregante?
- Tempo de evolução e Hb prévia conhecida? (crônico tolera valores muito mais baixos)

CLASSIFICAÇÃO POR VCM — ORIENTA A CAUSA

VCM	Tipo	Causas mais comuns no PS
< 80 (micro)	Microcítica	Ferropriva (perda GI/menstrual), talassemia, doença crônica
80-100 (normo)	Normocítica	Sangramento agudo, hemólise, doença crônica/DRC, mista
> 100 (macro)	Macroscítica	B12/folato, álcool, hipotireoidismo, mielodisplasia, hepatopatia

RED FLAGS — ANEMIA QUE NÃO PODE ESPERAR

SINAIS DE GRAVIDADE

- Instabilidade hemodinâmica: hipotensão, taquicardia, perfusão lenta, oligúria
- Sangramento ativo: hematêmese, melena, hematoquezia, sangramento vaginal intenso
- Sintomas isquêmicos: dor torácica, alteração do nível de consciência, dispneia em repouso
- ATENÇÃO: no sangramento agudo a Hb/Ht DEMORA a cair — decisão é CLÍNICA, não pelo número
- Anticoagulado com sangramento = considerar reversão específica precoce

EXAMES — O ESSENCIAL

SOLICITAR NO PS

- Hemograma completo (Hb/Ht, VCM, RDW, plaquetas) + reticulócitos
- Reticulócitos: ALTO = perda/hemólise | BAIXO = produção reduzida
- Tipagem + PAI / prova cruzada se QUALQUER chance de transfusão
- Função renal, eletrólitos, hepatograma (se suspeita de hemólise: LDH, BI, haptoglobina)
- Coagulograma se sangramento / anticoagulante / procedimento planejado
- Beta-hCG em toda mulher em idade fértil
- Ferritina + sat. transferrina: se ferropriva e cenário não urgente (pode ser ambulatorial)

GATILHOS TRANSFUSIONAIS — PACIENTE ESTÁVEL

Hb (g/dL)	Conduta	Observação
< 7	Em geral transfundir	Estratégia restritiva no estável
7 - 8	Considerar / individualizar	Transfundir se sintomático OU doença cardiovascular
> 8	Geralmente NÃO transfundir	Tratar causa e sintomas; só pelo número não justifica

CONDUTA POR CENÁRIO

Rx INSTÁVEL / HEMORRAGIA AGUDA

1. O2 se necessário + 2 acessos calibrosos
2. Cristaloide com parcimônia + aquecimento
3. Transfundir SEM esperar Hb cair (Ht ruim nas 1as horas)
4. Controle do foco: EDA / cirurgia / gineco
5. Sangramento maciço: protocolo de transfusão maciça
6. Reverter anticoagulação se aplicável

Rx ESTÁVEL — TRANSFUNDIR CH

- 1 unidade por vez na maioria dos estáveis
- Reavaliar clínica + Hb APÓS cada unidade
- Equipo com filtro; tempo máx 4h/bolsa
- Cardiopata/idoso: furosemida 20-40mg IV entre bolsas
- Ferro só se NÃO emergência + estável + ferropriva provável
- Sempre programar investigação da fonte de perda

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

INTERNAR SE

- Instabilidade hemodinâmica ou sangramento ativo
- Necessidade de transfusão repetida
- Sintomas importantes atribuíveis à anemia (síncope, dispneia de repouso, angina, confusão)
- Suspeita de hemólise grave ou anemia rapidamente progressiva
- Comorbidades descompensadas (IC, DAC, DPOC grave) com anemia

CHECKLIST DE ALTA SEGURA

ALTA SE

- ☐ Hemodinâmica estável, sem sangramento ativo
- ☐ Sintomas controlados
- ☐ Plano claro: investigação (GI/gineco), reposição se indicada, retorno programado
- ☐ Orientações de alarme: dispneia, síncope, dor torácica, melena/hematêmese/hematoquezia, sangramento vaginal intenso

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com anemia (Hb ____ g/dL) e quadro de ____ (sintomas / sangramento / instabilidade).
- Avaliação ABCDE; exames: hemograma, reticulócitos, função renal, coagulograma, tipagem/PAI.
- Estratificada necessidade transfusional pela clínica + limiares (restritivo Hb ~7-8 em estáveis, individualizando comorbidades).
- Conduta atual: ____ (transfusão / reposição / observação). Solicito ____ (vaga / avaliação especializada).

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Homem, 60a, hematêmese volumosa há 1h. PA 88/50, FC 122, sudoreico. Hb da admissão = 11 g/dL. Qual a conduta correta?

- A) Não transfundir: Hb 11 está acima do gatilho de 7 g/dL
- B) Aguardar nova Hb em 6h para decidir transfusão
- C) Reanimar e transfundir guiado pela clínica — a Hb ainda não reflete a perda aguda
- D) Iniciar ferro endovenoso imediatamente
- E) Transfundir apenas se Hb cair abaixo de 7 g/dL nas próximas coletas

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente estável, assintomático, Hb 7,5 g/dL, sem doença cardiovascular, em investigação de ferropriva. Conduta transfusional mais adequada?

- A) Transfundir 2 unidades de CH de imediato
- B) Não transfundir de rotina — estratégia restritiva; tratar causa e programar reposição de ferro
- C) Transfundir 1 unidade e repetir até Hb > 12 g/dL
- D) Transfundir somente se reticulócitos baixos
- E) Internar obrigatoriamente para transfusão diária

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual exame melhor separa anemia por aumento de perda/destruição de anemia por falência de produção?

- A) VCM isolado
- B) RDW isolado
- C) Contagem de reticulócitos
- D) Ferritina
- E) Dosagem de B12

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Mulher, 28a, anemia microcítica (VCM 72), menorragia há meses, hemodinamicamente estável, Hb 9 g/dL. Conduta inicial mais apropriada no PS?

- A) Transfusão imediata de concentrado de hemácias
- B) Mielograma de urgência
- C) Investigar/tratar a causa (ferropriva por perda menstrual), repor ferro e encaminhar — sem transfusão
- D) Iniciar B12 intramuscular
- E) Corticoterapia para suspeita de hemólise

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Idoso cardiopata (DAC), estável, com anemia normocítica e Hb 7,6 g/dL e dispneia leve aos esforços. Qual a melhor decisão?

- A) Não transfundir, pois Hb está acima de 7 g/dL
- B) Considerar transfusão pela faixa 7-8 g/dL associada a sintomas e comorbidade cardiovascular
- C) Transfundir apenas se Hb < 6 g/dL
- D) Indicar ferro EV e alta imediata
- E) Aguardar Hb < 7 g/dL obrigatoriamente antes de transfundir

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

No sangramento agudo, a Hb/Ht demora horas a refletir a perda (perde-se sangue total). A decisão de transfundir é CLÍNICA: instabilidade + sangramento ativo = reanimar e transfundir sem aguardar o número cair. Hb de admissão normal NÃO afasta perda grave.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Estratégia restritiva no estável: gatilho geral Hb < 7. Em 7-8 só transfunde se sintomático ou doença cardiovascular. Assintomático sem comorbidade = tratar a causa (ferro) e programar seguimento, sem transfusão.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Reticulócitos refletem a resposta medular: ALTOS sugerem perda/hemólise (medula respondendo); BAIXOS sugerem produção reduzida (falência medular, carências). É o primeiro divisor fisiopatológico da anemia.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Microcitose + menorragia = ferropriva por perda menstrual. Estável e Hb 9 não exige transfusão; conduta é repor ferro, tratar a fonte e encaminhar para investigação ambulatorial. Mielograma e B12 não se aplicam aqui.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Faixa 7-8 g/dL é zona de individualização: a presença de doença cardiovascular (DAC) e sintomas (dispneia) pesa a favor de transfundir. Em comorbidade cardíaca aceita-se limiar um pouco mais liberal que no jovem hígido.

SM24
Suporte ao Plantão Médico